

사상체질의학 9주차

01 총론

초반에 프리스타일로 질문공격하시던 부분은 제외함.

알고있어야 한다고 언급한것들.(전체범위):사상체질 병증명 / 이제마가 만든 체질병 처방들.

원문 나가시기전 설명은 프리스타일랩 하신거라 뒤죽박죽이라 순서편집.

원문을 임상적으로 어떻게 사용할 수 있는지가 중요: 병증-증상-처방

처방과 구성약재: 태음인+태양인은 구성약재까지 제대로 알 것

본문 빨간 글씨가 중요한 내용! 빨간 글씨 위주로 공부하면 될 듯

보면 알겠지만..기출 잘은 안타고..여기저기 중요한데서 다양하게 많이 나옴 참고 必

證의 관찰 ★★보명지주, 완실무병

	태과	보명지주	완실무병	大病	특이증후
太陽人	呼散之氣	吸聚之氣	小便旺多	口中吐沫	噎膈則胃脘之上焦散豁如風
少陽人	納積之氣	陰清之氣	大便善通	大便不通	大便不通則胸膈必如烈火
太陰人	吸聚之氣	呼散之氣	汗液通暢	陽剛堅密	痢病則小腸之中焦窒塞如霧

少陰人	出放之氣	陽煖之氣	飲食善化	腹痛泄瀉	泄瀉不止則臍下必如冰冷
-----	------	------	------	------	-------------

태양인은 자꾸 빠져나가니까 흡취지기가 보명지주가 되고 이러한 보명지주가 건강하게 잘 이루어진 상태가 완실무병이고 소변이 왕성해서 많은상태(그정도로 많이 나가도 될 정도로 몸의 체액량이 충분하다는 뜻)

태음인은 순환이 잘 되어야하기 때문에 땀이 잘 나는 것이 완실무병.

갑오본과 경자본의 병증 인식 차이

갑오본 (1894)	- 태양, 소양, 태음, 소음인 - 모든 사람은 몸의 가장 약한 부위(=편소지장)에 병이 발생한다는 개념 - 편소지장 중심으로 편명을 붙임 (ex.요척, 방광, 뇌추, 려, 소장, 대장, 위안, 위 등)
경자본 (1900)	- 경자본의 소음,소양,태음인 + 갑오본의 태양인 - 순환, 한열/승강, 편소지장과 반대지장을 고려해서 가장 병리를 설명 - 체질에 따라서 몸의 약한 부위에 병이 발생할 수도 있고, 몸의 강한 부위에 병이 발생할 수도 있다 + 순환 + 한열/승강의 개념 도입 - 순환 개념이 가장 크게 더해짐 ∴ 순환, 팔강(음양표리한열허실)의 개념을 통해 더 고도화가 되었음

->작은 장기중심으로 보던 시각이 빠지며 신축본에서는 보명지주라는 용어가 등장하진 않았으나 경중허위를 구분하는 기준에 보명지주의 개념은 사용되었음.

+ 동역수세보원 갑오본 경자본에서 태음인 병증분류의 차이

조열병 (갈근해기탕병증)	갑오본	표병으로 분류	증상이 表에 나타나므로
	경자본	리병으로 분류	원인이 간열로부터 비롯되었으므로

동역수세보원 3가지 ver. ★ 기출

연도	판본	저자	내용				
1894	갑오본	이제마	원리론	소음인	소양인	태음인	태양인
1900	경자본	이제마	○	○	○	○	×
1901	신축본	울동계	○	○	○	○	○

이제마: 1837출생(응애) 1900사망(애응) / *울동계 = 이제마 제자들

-경자본: 이제마가 죽을때쯤 다시 작성한 책인데 태양인은 작성하지 못하고 애응하심.

-신축본: 따라서 이제마 제자들이 이제마 애응1주기 기념 책내자!->신축본.

->태양인은 이제마가 고치지 못했으니까 갑오본 병증 그대로 들어감.

사상체질병증(교과서 기준) ★ 기출

체질	표증		리증	
소음인	울광증	망양증	태음증	소음증
소양인	소양상풍증	망음증	홍격열증	음허오열증
태음인	배추표병증	위완한증	조열증	음혈모갈증
태양인	해역증	해역겸열격	열격증	열격겸해역

표증/리증명: 갑오본 vs 경자본 ★ 기출

갑오본 버전 명칭 (1894)

	표병	리병
태양인	외감요척병론(外感腰脊病論)	내촉소장병론(內觸小腸病論)
소양인	외감방광병(外感膀胱病)	내촉대장병(內觸大腸病)
태음인	외감뇌추병(外感腦顚病)	내촉위완병(內觸胃脘病)
소음인	외감려병(外感膺病)	내촉위병(內觸胃病)

경자본,신축본 버전 명칭(1900)

	표병	리병
태양인	외감요척병론(外感腰脊病論)	내촉소장병론(內觸小腸病論)
소양인	비수한표한병론(脾受寒表寒病論)	위수열리열병론(胃受熱裡熱病論)
태음인	위완수한표한병론(胃脘受寒表寒病論)	간수열리열병론(肝受熱裡熱病論)
소음인	신수열표열병론(腎受熱表熱病論)	위수한리한병론(胃受寒裡寒病論)

- 갑오본 시각: 우리 몸에서 가장 약한 부분에 병이 생김

㉔ 경자본 시각: 가장 약한 부분에 병이 생기지만, 현상적으로는 다른 부분에 증상이 나타날 수 있음 → 정확하게 병리, 증상을 표현하기 위해 편명을 바꿈

소음인	소양인	태음인	태양인
신대비소	비대신소	간대폐소	폐대간소
사초(四焦)	사장(四藏)	사부(四腑)	후사해의 부위
상초	폐	위완	두뇌(두)
중상초	비	위	배려(견)
중하초	간	소장	요척(요)
하초	신	대장	방광(둔)

명칭에 대한 설명)

갑오본)

갑오본에서는 약한 장기에서 병이든다고 생각했음->표병에는 후사해의 약한장기 / 리증에는 사부의 약한장기의 이름이 들어감.

Ex)

태음인: 간대는 필요없고 폐소만 생각 ->폐에 해당되는 위완, 두뇌가 약하다!->외감뇌추병 / 내축위완병.

- 태음인 : 폐소-폐가 약함-폐는 상초에 해당-상초로 병이 온다 → 외감뇌추병/내축위완병
- 태양인: 간소-간이 약함-간은 중하초에 해당-중하초로 병이 온다 → 외감요척병/내축소장병
- 소음인: 비소-비가 약함-비는 중상초에 해당-중상초로 병이 온다 → 외감려병/내축위병
- 소양인: 신소-신이 약함-신은 하초에 해당-하초로 병이 온다 → 외감방광병/내축대장병

경자본)

갑오본에서는 약한장부만이 문제라고 생각했으나 제마해임 임상을 하다보니 큰장부도 문제라는

것을 깨달음!

->태음인은 간대폐소-> 상초가 작고 중하초가 큰 기관->위완,폐가 약하고 소장,간이 강한기관! ->위완수한리한병 , 간수열리열병. (다만 사부가아니라 사장이 들어가는 병증명도 있음. 강한장기도 고려하기 시작했다는게 포인트)

->이런식으로 소음,소양,태음,태양인에 대응시킬 수 있다.

크다는건?

발달하고 건강하다는 의미가 아니라 향진될 가능성이 있다는 의미이고 작은장부의 기운을 끌어다쓴다는 의미 내포. ->간이 커진다->폐가 작아지게 되고 폐의취약유발, 간의향진

처방 및 약재 ★ 기출

- 신정방(67개) 및 약재(130개) *태양인/태음인은 처방 구성까지 다 암기

체질	처방 개수	약재 개수
소음인	24	40
소양인	17	36
태음인	24	44
태양인	2	10

*신정 = 새로 정한다 (즉, 이제마가 새로 정한 처방이 신정방)

보명지주와 완실무병 ★ 기출

- 보명지주: 생명을 보하는 주된 기운
- 완실무병: 사상인 보명지주가 완전하게 공급돼서 건강하고 병이 없는 상태

	체질정기(보명지주)	완실무병(完實無病)
태양인	흡취지기(吸聚之氣)	소변왕다(小便旺多)
소양인	음청지기(陰淸之氣)	대변선통(大便善通)
태음인	호산지기(呼散之氣)	한액통창(汗液通暢)
소음인	양난지기(陽煖之氣)	음식선화(飲食善化)

수곡 기액의 대사 ★ 기출: 간폐가 호흡하는 물질?

- 비&신: 수곡지기 대사 (상하로 수곡 한열의 승강 조절) * 소화-배설기계

✓ 소양인/소음인 → 수곡지기 병증 → 현상으로 나타나는 것이 소화, 대변

비	신
수곡을 받아들이는(납적) 기능(열)	수곡을 내보내는(출방) 기능(한)
소화	대변

- 폐&간: 기액지기 대사 (표리로 기액 호흡의 완속 조절) * 호흡-순환기계

✓ 태양인/태음인 → 기액지기 병증 → 현상으로 나타나는 것이 땀, 소변

폐	간
기액을 내뿜는(호산) 기능(온)	기액을 모으는(흡취) 기능(량)
땀	소변

[태음인 위완수한표한병]

0. 개괄

1. 태음인 표증

1.1. 배추표병

- 배추표병 경증

- 배추표병 중증

1.2. 위완

프리스타일 총론)

표:통증이 나타나는 부분

리: 소화,설사,변비 같은 형상이 일어나는 부분

옛날에는 땀, 소변이 둘다 덩어리가 아니라 수분이기 때문에 정미로운 에너지를 가진 물질이라고 생각했고 기액이라고 생각했다. 따라서 땀,소변배출이 잘 안되는 병증을 기액지기 병증이라고 했다.

1. 태음인 표증

Intro

✓ 태음인 병증 및 대표처방

위완수한표한병	경	배추표병증	마황발표탕
<표병&순증>	중	위완한증	태음조위탕
간수열리열병	험	조열증	열다한소탕
<리병&역증>	위	음혈모갈증	공진흑원단

✓ 태음인 위한수한표한병

= 위완에 한을 받아서 표에 한이 나타나는 병

- 태음인 표병 처방의 대표적 약재는 마황 / 건울(밤), 의이인(울무) → 태음조위탕, 한다열소탕

✓ 태음인 간수열리열병

= 간에 열을 받아서 리에 열이 나타나는 병

- 태음인 리병 처방의 대표적 약재는 갈근, 대황 → 열다한소탕, 갈근해기탕

1.1. 배추표병

*[12-1] ~ [12-3] 배추표병 경증 / [12-4] ~ [12-10] 배추표병 중증 / [12-11]부터 위완한증

배추표병 경증 ★기출: 본문 빈칸(喘) / 증상 → 병증명&처방 쓰기

[12-1] 張仲景曰, 太陽傷寒, 頭痛發熱, 身疼腰痛, 骨節皆痛, 惡寒無汗而喘, 麻黃湯主之.

장중경(張仲景)이 말하기를 태양병 상한(太陽病 傷寒)에 두통이 있고 열이 나며 전신이 쑤시고 요통이 있고 뼈마디가 쑤시고 아프며 오한이 있으나 **땀이 나지 않고 기침**을 하면 마황탕(麻黃湯)을 쓴다.

- 이 조문에서 태음인과 관련한 아이디어를 얻은 증상: **喘** (간대폐소와 관련⇒호흡기 증상)

- 소음인 울광증도 무한의 특징이 있는데, 울광증의 무한과 태음인에서의 무한의 기준이 다르다
'소음인 무한: 양기가 빠져 나가지 않음을 의미 (소음인이 땀나면 황기, 인삼으로 고표지한)

'태음인 무한: 순환이 안됨을 의미 (12-2로 이어짐)

->위의 보명지주 설명을 떠올려 주세요!

[12-1] 註曰, 傷寒, 頭痛身疼腰痛, 以至牽連, 百骨節, 俱痛者, 此太陽傷寒, 榮血不利, 故也.

주석으로 말하기를 상한에 두통이 나고 몸과 허리가 아픈 증세를 오래 끌어오다가 골절이 쑤시고 아프면 이는 태양병 상한으로 영혈(營血)이 고르지 못한 연고다.

- 1940년 한두정: '장중경이, 태양상한에, 두통발열하며~' ⇒ 구결, 현토를 달아둠

- 註: 주석단 사람 ⇒ 주굉(상한론주석담)

- 영혈불리: 기액 순환이 안되어, **땀이 나지 않는 상황**

→ 무한의 기전이 영혈불리에 있음을 이제마가 깨달은 것

✓언급하신 내용: 기출 [首: 장중경, 주굉, 허준 / 次: 이천, 공신]

[5-1] (생략) 若以醫家勸勞功業, 論之, 則當以張仲景, 朱肱·許浚, 爲首, 而李梴·龔信, 次之

(생략) 만일 의가의 공로와 업적으로 말한다면 마땅히 장중경·주굉·허준을 으뜸이라 해야 할 것이며, 이천과 공신이 그 다음이라고 해야 할 것이다.

공신: 형방패독산, 곽향정기산을 창방.

★ 기출: 본문 증상 → 병증명&처방 쓰기

[12-2] 論曰, 此, 卽太陰人傷寒, 背𩑦表病輕證也. 此證, 麻黃湯, 非不當用, 而桂枝甘草, 皆爲蠱材, 此證, 當用麻黃發表湯.

이를 태음인(太陰人)의 상한 **배추표병경증**(背佳眞表病輕證)이라 하였다. 이 증에 **마황탕**이 사용되었으나 계지와 감초는 불필요한 것이며 마땅히 **마황발표**

탕을 사용해야 한다.

- '논알~': 이제마의 의견, 고찰

- 해석: 마황탕을 쓰지 못할 것은 아니지만, 계지/감초는 좀먹는 재료 (蠹:좀먹을 두)

→ 태음인 배추표병에 마황탕으로 치료를 할 수는 있지만 계지, 감초가 들어가서 약효를 해친다

→ 상한론 개념으로 본다면 상한표실증에 속함

배추표병증이 더 심해지면 한결증이 됨.(장감병이라고도 하며 사상의학에서는 한결증이라 한다.

한결증: 출기는 추운데 열이나지 않는 증상. 땀을 조절하는 자율신경이 망가진 경우를 의미.

(현대에서는 양방 정신과약의 부작용. 졸피뎀,디아제팜등의 수면제 혹은 스테로이드)

->추워서 덜덜떠는데 열은 없고 정서적 불안한 조짐, 뇌,자율신경계,내분비계의 이상.

✓ 마황탕vs마황발표탕 ★ 기출: 마황발표탕에는 있으나 마황탕에 없는 약재?

마황탕 = 마황 3돈 + 행인 10개 + 계지 2돈 + 감초 6푼 + 강3조2

- 계지, 감초 = 소음인 체질 약 → 계지 감초가 들어가면서 약효를 해치므로 빼야한다

마황발표탕 = 마황 1돈 5푼 + 행인 1돈 + 길경 3돈 + 맥문동 + 황금

cf) 소음인: 계지탕 → 황기계지탕, 천궁계지탕 / 소양인: 소시호탕 → 형방패독산 / 황금은

오히려 간독성을 야기할수도 있음.

배추표병 증증

[12-4] 張仲景曰, 傷寒四五日, 而厥者, 必發熱, 厥深者, 熱亦深, 厥微者, 熱亦微. 傷寒厥四日, 熱反, 三日, 復厥, 五日, 厥多熱少, 其病爲進. 傷寒發熱四日, 厥反, 三日, 厥少熱多, 其病當自愈.

장중경이 말하길, 상한 4~5일에 결증(厥證)이 있는데 반드시 발열이 있다. 결

(厥)이 심한 것은 열도 심하고 결이 미약한 것은 열도 미약하다. 상한병에 결 4일에 발열은 3일하고 다시 결 5일하는 것은 **결다열소(厥多熱小)**로서 그 병이 진행되는 것이다. 상한병에 발열 4일하고 결 3일하는 것은 **결소열다(厥小熱多)**로서 그 병은 스스로 낫는다.

- 결(厥): 오한을 포함하는 寒證 범주 / 복결(復厥): 다시 오한 생김 / 심(深): 깊이(안쪽으로) 들어감

「결다열소: 결, 즉 한증의 상황이 더 많음 → 병이 진행

「결소열다: 열이 나는 상황이 더 많음 → 병이 나음 ⇒ 정기가 살아있는 증거=발열

교수님 생각엔, 패혈증 sepsis와 비슷하다고 생각하심. 열이 날 때는 환자가 스스로 회복될 여력이 있는 것, 면역기능이 있음 but 정신 또렷하지x&열이 오히려 떨어지면 거의 죽는다고 생각 (산소포화도 떨어진 상태)

[12-4]

1) 論曰, 此謂之厥者, 但惡寒不發熱之謂也, 非手足厥逆之謂也. 太陰人, 傷寒表證, 寒厥四五日後, 發熱者, 重證也,

2) 此證, 發熱, 其汗必自髮際, 而始通於額上, 又數日後發熱, 而眉稜通汗, 又數日後發熱, 而額上通汗, 又數日後發熱, 而脣頤通汗, 又數日後發熱, 而胸臆通汗也, 而額上之汗, 數次, 而後, 達於眉稜, 眉稜之汗, 數次, 而後, 達於額上, 額上之汗, 數次, 而後, 達於脣頤, 脣頤之汗, 不過一次, 而直達於胸臆矣.

3) 此證, 首尾幾近二十日, 凡寒厥六七次, 而後病解也, 此證, 俗謂之長感病. 凡太陰人病, 先額上眉稜, 有汗, 而一汗病不解, 屢汗病解者, 名曰長感病.

1) 이른바 결이라 함은 단지 오한만 있고 발열이 없음을 말한 것이요, 수족(手

足)의 궤역(厥逆)을 말한 것이 아니다. 태음인 상한 표증에 있어서 **한궤(寒厥)**이 된지 4, 5일후에 열이 나는 것은 **중증(重證)**이다.

- 2) 이 증세에 열이 오르고 땀이 날 때에는 반드시 **발제(髮際)**에서 시작하여 **이마**로 통하고 며칠 후에 다시 열이 오르다가 **눈썹** 가에 땀이 통하고 또 며칠 후에는 열이 오르다가 **뺨(광대)**에서 땀이 나고 다시 며칠 후에는 열이 오르다가 **입술과 턱**에서 땀이 통하고 또 열이 오르다가 **가슴**에서 땀이 통한다. 이와 같이 이마에 땀이 몇 차례 난 뒤에는 눈썹 가에 이르고 눈썹 가에 땀이 몇 차례난 뒤에는 뺨에 이르고 뺨에 땀이 몇 차례난 후에는 입술과 턱에 이르러 불과 한차례 땀이 난 다음에 곧바로 가슴으로 통한다.
- 3)이 병 증세가 처음 시작하여 병이 낫기까지 근 20일이 걸려 한궤이 6, 7차 반복한 후에 풀리는데 이를 사람들은 장감병(長感病)이라 한다. 대체로 태음인 병은 먼저 이마 위와 눈썹 가에서 땀이 나는데 한 번 땀이 났는데도 병은 풀리지 않고 여러 번 땀을 낸 후 비로소 풀리는 것을 **장감병**이라고 하는 것이다.

- 論曰(논왈): 경자본(1900)

- 今考更定(금고경정:지금 와서 생각해서 다시 정한다): 갑오본(1894)

⇒ 갑오본의 ‘금고경정’이 더 센 어투(시간이 지나면서 경자년 버전에서 좀 겸손해진거 같다는 말씀)

- 태음인에서는 배추표병에 모두 해당하지만,

배추표병 경증: 무한&천 - 마황발표탕

장감병=한궤증=배추표병 중증: 오한불발열(=정기가 스스로 병균 못죽임) - **웅담산, 한다열소**

탕

여기서 뽀인트는 땀

髮際(발제)→ 額上(액상)→ 眉稜(미릉)→ 顴上(관상)→ 脣頤(순이)→ 胸臆(흉억)

★순서:발제→ 이마→ 눈썹→ 광대뺨→ 입술, 턱 →가슴

→ 땀이 나는 부위가 위에서부터 아래로 내려옴

→ 땀의 양과 관련있다고 생각하심 (전체적 양이 많아야, 중력에 의해 아래로 내려오기 때문에)

⇒ 땀이 많이 날수록(=아래로 내려올수록) 병이 풀림 / 땀이 적게 날수록(=위로 올라갈수록)

병이 심해짐

마지막에 흉억에 땀이 나면 완전히 풀린다

한궤증: 오한불발열/열은 나지 않지만 땀이 나는 것/땀의 부위와 양이 포인트

★ 기출: 본문 증상 → 병증명

[12-5]

1)太陰人病, 寒厥六七日, 而**不發熱不汗出**(sepsis의 마지막 단계), 則死也. 寒

厥二三日, 而發熱汗出, 則輕證也,

2)寒厥四五日, 而發熱, 得微汗於額上者, 此之謂長感病, 其病, 爲重證也. 此

證原委, 勞心焦思之餘, 胃脘衰弱, 而表局虛薄不勝寒, 而外被寒邪所圍, 正

邪相爭之形勢, 客勝主弱, 譬(비유)如一團孤軍, 困在垓心, 幾於全軍覆沒之

境, 先鋒一隊, 倖而跳出, 決圍一面, 僅得開路, 後軍全隊, 尙在垓心, 將又

屢次力戰然後, 方爲出來則爻象, 正是凜凜之勢也.

3)額上通汗者, 卽先鋒一隊, 決圍跳出之象也, 眉稜通汗者, 卽前軍全隊, 決圍

全面, 氣勢勇敢之象也, 顴上通汗者, 中軍半隊, 緩緩出圍之象也, 此病, 汗

出眉稜, 則快免危也, 汗出顴上, 則必無危也.	
1)태음인 병에 한궐 6~7일에 열이 나지 않고 땀도 나지 않으면 죽는다. 한궐 2~3일에 발열과 한출(汗出)이 있으면 경증(輕證)이다.	
2)한궐 4~5일에 발열하고 이마 위에 약간 땀이 나는 것은 장감병으로 중증(重證)이다. 이 병의 원인은(此證原委) 노심초사(勞心焦思)하여 위완(胃脘)이 쇠약해지고 표(表)가 허박(虛薄)해져서 한사(寒邪)를 이기지 못하고 한사에 에워싸여 정기(正氣)와 사기(邪氣)가 서로 싸우는 형세인데 객(客)이 이기고 주인이 약한 것이다. 전장의 전세에 비유컨대 포위를 당하고 있는 외로운 군대가 포위망 속에서 거의 전군대가 모두 몰락의 위기에 있다가 선봉일대가 요행으로 뛰어나가서 결사적으로 전투를 하여 겨우 포위망을 뚫어 놓기는 하였으나(僅得開路) 후군 전대가 아직 포위망 속에 있으니 앞으로도 여러 차례를 전투를 한 다음에야 전군이 모두 나올 수 있게 되었으니 효상(爻象)이 진실로 능름한 기세인 것이다.	
3)액상(額上)에서 땀이 나온 것은 선봉일대가 결사적으로 포위진을 뚫고 뛰어나오는 상이오 미릉(眉稜)에서 땀이 나는 것은 전군 전대가 적진을 무찌르는 용감한 상이오 관상(顴上)에서 땀이 나는 것은 중군 반대(中軍 半隊)가 천천히 포위를 뚫고 나오는 상이니 이 병에서 미릉에서 땀이 나오면 위급한 것을 꺾히 면한 것이고 관상에서 땀이 나는 것은 병이 위급하지 않은 것이다.	

- 같은 얘기인데, 비유를 한 것: 전쟁상황에 비유함

額上(액상)	先鋒一隊, 決圍跳出之象
眉稜(미릉)	前軍全隊, 決圍全面, 氣勢勇敢之象

顴上(관상)	中軍半隊, 緩緩出圍之象
脣頤(순이)	快免危
胸臆(흉억)	必無危

┌순증: 보명지주 손상x ⇒ 경증(▷배추표병경증) / 중증(▷한궐증=장감병=배추표병중증)

└역증: 보명지주 손상o ⇒ 험증 / 위증

㉠ 불발열불한출: 발열x, 땀x ⇒ sepsis의 마지막 단계

㉠ 위완쇠약: 태음인은 간대폐소 - 폐가 약함 - 상초에 해당하는 위완이 약해짐

┌ 경증: 마황발표탕으로 풀리는 배추표병 경증에 해당 (일반적 감염 상황)

└ 중증: 땀이 아래로 안 내려오고, 이마 위에 땀 나면 장감병

★ 기출: 쾌한/비쾌한의 양상, 정강사약/정약사강 빈칸

[12-6] 太陰人汗, 無論顴上, 眉稜上, 顴上, 汗出如黍粒, 發熱稍久而還入者, 正強邪弱, 快汗也. 汗出如微粒, 或淋漓無粒, 乍時而還入者, 正弱邪強, 非快汗也.	
태음인 땀은 이마 눈썹 뺨을 막론하고, 땀방울이 기장알 같이 굵어야 하며 또 열이 약간 오래 있다가 들어가면 정기가 강하고 사기가 약한 것이니 상쾌한 땀이지만 / 만일 땀방울이 적고 또 방울이 없이 잠시 후에 들어가면 정기가 약하고 사기가 강한 것이니 상쾌하지 못한 땀이다.	

- 黍: 기장 서 (방울방울 맺혀서 덩어리가 지는 것) / 乍: 잠깐 사

┌쾌한: 땀방울이 기장알 같이 굵어야 하며 또 열이 약간 오래 있다가 들어가는 경우: 정강사약

└비쾌한: 땀방울이 적고, 방울이 없이 잠시 후에 들어가는 경우: 정약사강

⇒ 결국 땀의 양과 관련된 내용 / 쾌한은 순환이 된다는 것을 의미한다.(과식했다가 뽕뽕하면

좀 편안해지고 , 이런것을 의미함.)

★ 기출: 땀이 나기 시작하는 부위[발제지한]와 병이 크게 풀리면서 낫는 부위[흉역지한]

[12-7]

1)太陰人, 背部後面, 自腦以下, 有汗, 而面部髮際以下, 不汗者, 匈證也.
全面, 皆有汗, 而耳門左右, 不汗者, 死證也.

2)大凡太陰人汗, 始自耳後高骨, 面部髮際, 大通於胃臆間, 而病解也.
髮際之汗, 始免死也, 額上之汗, 僅免危也. 眉稜之汗, 快免危也, 顴上之汗, 生路寬闊也. 脣頤之汗, 病已解也, 胸臆之汗, 病大解也.

3)嘗見此證, 額上汗, 欲作眉稜汗者, 寒厥之勢, 不甚猛也.
顴上汗, 欲作脣頤汗者, 寒厥之勢, 甚猛, 至於寒戰叩齒, 完若動風而其汗, 直達兩腋,

4)張仲景所云, 厥深者, 熱亦深, 厥微者, 熱亦微, 盖謂此也. 此證, 寒厥之勢, 多日者, 病重之勢也. 寒厥之勢, 猛峻者, 非病重之勢也

1)태음인이 등 뒤 목덜미 아래에는 땀이 있어도 얼굴 발제(髮際) 아래로 땀이 나지 않는 것은 흉(匈)한 병세이고
또 얼굴 전면에 땀이 있어도 양쪽 이문(耳門)에서 땀이 나지 않는 것은 죽는 증세이다.

2)대체로 태음인의 땀은 귀 뒤의 높은 뼈와 안면 발제에서 시작하여 젖가슴에서 크게 통하면 이는 병이 풀리는 것이고, 발제의 땀은 비로소 죽음을 면하기 시작한 것(始免死)이고 이마에서 나는 땀은 겨우 위험을 면하는 것(僅免危)이고 눈썹 가에서 나는 땀은 위험을 완전히 면한 것(快免危)이고 뺨에서

나는 땀은 살길이 넉넉히 활짝 열린(生路寬闊) 땀이고 입술과 턱에서 나는 땀은 병이 이미 풀린 것이고 젖가슴에서 나는 땀은 병이 완전히 풀린 것이다.

3)대체로 모든 태음인의 땀은 귀 뒤 높은 뼈와 안면발제에서부터 시작하여 젖가슴에서 크게 통한하면 병이 풀리는 것이다. 일찍이 이마에서 땀이 나기 시작하여 눈두덩위에 땀이 나려고 할 때에는 한귀를 일으키는 증상이 맹렬하지 못하고, 뺨 위의 땀이 나서 입술과 턱에 일으키려는 땀은 한귀가 몹시 맹렬하여 한전(寒戰)을 일으켜 이빨을 부딪치면서 턱을 떠는 것이 완전히 동풍(動風)증을 일으킬 것처럼 되더니 그 땀이 양쪽 겨드랑이 밑으로 곧장 도달하는 것이다.

4)장중경이 말한 곁이 심한 것은 또한 열이 심하다 하였고 곁이 미약한 것은 또한 열도 미약하다 한 것은 모두 이 한귀하는 병증을 보고 이르는 말이다. 이 병증에서 한귀하는 증상이 여러 날 계속하는 것은 그 병이 중증이 되려는 형세이고 한귀하는 증상이 몹시 맹렬한 것은 중증이 될 병세가 아니다.

1)
 └ 匈증: 등뒤~후두부 땀o&얼굴에 땀x
 └ 死증: 얼굴에 땀o&양쪽 이문(귀옆)에 땀x ⇒ 굳이 설명하자면 염증이 심해진 상황
⇒ 배부, 외이(귀) [뒤쪽]에서부터 시작하여,
발제-액상-미릉-관상-순이-흉역 [앞쪽]까지 땀이 쪽 나야 좋은 것

2) 땀의 부위

髮際(발제)	始免死(시면사): 비로소 죽음을 면함
--------	----------------------

額上(액상)	僅免危(근면위): 겨우 위험을 면함
眉稜(미릉)	快免危(쾌면위): 위험을 완전히 면함
顴上(관상)	生路寬闊(생로관활): 살길이 활짝 열림
脣頤(순이)	病已解(병이해): 병이 이미 풀림
胸臆(흉억)	病大解(병대해): 병이 완전히 풀림

3) 병이 풀리는데 고비가 있음: 한꺠(=오한불발열)

┐ 이마→눈썹 사이로 내려올 때: 한꺠 심하지x

└ 광대→입술로 내려올 때: 한꺠 심함 ⇒ 이때는 병이 풀리려고 하기 직전의 상황

⇒ 오한불발열이 극심하다고 병이 심해지는 것이 아니라, **날짜**가 중요 (오래되면 중증이 되려는 것)

오히려 오한불발열이 심하면 병이 풀리려 하는 것

[12-8]

1)此證, 京畿道人, 謂之**長感病**, 咸鏡道人, 謂之**四十日痛**, 或謂之**無汗乾病**, 時俗所用荊防敗毒散・藿香正氣散・補中益氣湯, 箇箇誤治. 惟**熊膽**, 雖或**盲人直門**, 然, 又連用他藥, 病勢更變, 古人所云, 病不能殺人, 藥能殺人者, 不亦信乎.

2)百病加減之勢, 以凡眼目觀之, 固難推測, 而此證, 又有甚焉, **此證(한꺠증)**之汗, 在眉稜顴上時, 雖不服藥, 亦自愈矣, 而病人, 招醫, 妄投誤藥, 則顴上之汗, 還爲額上之汗, 而外證寒厥之勢, 則稍減矣. 於是焉, 醫師, 自以爲信藥

效, 病人, 亦自以爲得藥效, 又數日誤藥, 則額上之汗, 又不通, 而死矣.

此證, 當以**汗之進退**, 占病之輕重, 不可以**寒之寬猛**, 占病之輕重,

3)張仲景曰, 其病, 當自愈云者, 豈非珍重無妄之論乎. 然, 長感病, 無疫氣者, 待其自愈, 則好也, 而瘟疫, **疫氣**重者, 若明知證藥無疑, 則不可尋常置之, 待其勿藥自愈, 恐生**奇證**.

1)이런 증세를 경기도 사람은 **장감병**이라 하고 함경도 사람은 **사십일통(四十日痛)**이라 하고 혹은 **무한건병(無汗乾病)**이라고 하여, 흔히 쓰는 약이 **형방패독산(荊防敗毒散)・곽향정기산(藿香正氣散)・보중익기탕(補中益氣湯)**인데, 모두 이병을 잘못 치료하는 것이니 오직 **웅담(熊膽)**이 혹 **맹인직문(盲人直門)**격으로 잘 듣는 수가 있는 것이다. 그러나 웅담을 쓰고도 다른 적당치 못한 약을 이어 쓰면 병세가 다시 변하는 것이다. 옛사람이 병이 사람을 죽이는 것이 아니라 약이 능히 사람을 죽일 수 있다 하였으니 과연 믿지 않을 수 있겠는가.

2)모든 병이 더하고 덜 하는 증상을 보통 식견으로 보고 추측하며 알기 어려워 더욱 이 병증은 더욱 심한 것이다. 이 병증에서 땀이 미릉과 관상에서 나오면 그런 때는 약을 쓰지 않아도 병이 스스로 나올 수 있는 것인데 병인이 의사를 불러 오게 하여 적당치 못한 약을 투약하면(망투오약) 관상에서 나오던 땀이 다시 액상으로 올라가면 외증(外證)인 한꺠하는 증세가 좀 덜하게 되어 이것을 보고 의사는 자기의 약효가 난다고 믿고 또한 병인도 약효가 있다고 생각을 하여 또 잘못된 약을 며칠 더 쓰면 이번에는 액상에서 나오던 땀마저 끊어져 죽는 것이다. 그러므로 이 병은 **땀의 진퇴**로서 경중을 알 것이고, **한꺠하는 증상이 맹렬하고 미약한 것**은 병의 경중을 점쳐서는 안 된다.

3)장중경이 말하기를 그 병증에 약을 쓰지 않아도 스스로 나올 수 있다고 한

것이 어찌 진중하고 거짓이 없는 말이 아니겠는가? 그러나 장감병에 있어서 **역기(疫氣)**가 없는 환자는 스스로 낫기를 기다려도 좋겠으나, 온병(瘟病)에 역기가 심한 사람은 병증과 약성을 밝게 알고 의심할 것이 없이 밝게 안다면 약을 쓰지 않고 심상하게 두어 병이 스스로 낫기를 기다려서는 안 된다. 그렇게 하면 **기증(奇證)**이 생길까 두렵기 때문이다.

1) 장감병=사십일통=무한건병=한궤증

☞ 마황 들어간 것을 써야 치료가 되는데, **인삼/곽향(=형방패독산, 곽향정기산, 보중익기탕)** 쓰니까 치료 안되는 것 ⇒ **웅담**이나 한다열소탕을 써야함!

- **맹인직문(盲人直門)**: 운 좋게 맹인이 문을 바로 찾은 것 ⇒ **웅담을 비유한 것**

2) 100가지 병의 가감을 살펴보건데 추측하기 어려움. 특히, 장감병은 더욱 추측하기 어렵

☞ 미륵/관상에 땀: 가만히 두면 낫는데 → 약 잘못 써서, 광대뼈 땀이 다시 이마로 올라감 → 오한이 줄어들 → 이걸 보고 의사는 (잘못된 것인데) 자기가 잘한줄 알고 잘못된 약 계속 씬 → 이마 땀마저 안 나와서 죽음

⇒ **땀의 진퇴(땀이 나는 부위)로 경중을** 알아야지, **한궤(오한불발열)와 맹렬한 정도로 경중** 알면x

3) 장중경: 상한론에서 한궤증은 약 쓰지 않아도 저절로 나옴

豈非珍重無妄之論乎: 망령되이 생각하지 말아야 할 보석 같은 말이다

- 역기(疫氣): 오한불발열 이외의 다양한 감염의 증상 - ex) 기침, 가래, 얼굴 붉어짐

- 기증(奇證): 이상한 증상

장감병에 역기가 없는 상황 : 저절로 나오니까 기다려도 괜찮음

‘but 역기가 심한 사람: 약 쓰지 않고 스스로 낫길 기다리면x ⇒ **웅담산이나 한다열소탕** 써야함

역기가 심한 경우에 저절로 낫기를 기다리면 기증(이상한증상)이 생긴다

☞ 약 잘못 쓰지 말고, 잘못 쓸 바에는 기다리는게 나옴 but 역기(오한불발열 이외 다른 다양한 감염의 증상)이 생기면 약(한다열소탕, 웅담)을 써야한다

★ 기출: 본문 증상 → 병증명 / 한궤증의 처방 / 태음인 대변에 따른 가감

[12-9] 論曰, 太陰人病, 寒厥四日, 而無汗者, 重證也. 寒厥五日, 而無汗者, 險證也. 當用**熊膽散**, 或**寒多熱少湯**, 加**蟪蟪五七九介**.

大便滑者, 必用**乾栗**·**薏苡仁**等屬.

大便燥者, 必用**葛根**·**大黃**等屬.

若額上眉稜上, 有汗則待其自愈, 而病解後, 用藥調理, 否則恐生後病.

태음인 병이 한궤 4일에 무한자(無汗者)는 중증이고, 한궤 5일에 무한자는 험증이니

마땅히 **웅담산**을 쓰거나 혹 **한다열소탕(寒多熱少湯)**에 **제조(蟪蟪) 5,7,9개**를 **가(加)**하되,

대변 묽으면 반드시 **건율(乾栗)**·**의이인(薏苡仁)** 등을 써야하고,

대변이 굳으면 **갈근(葛根)**·**대황(大黃)** 등속을 써야한다.

만약 이마, 눈두덩 위에서 땀이 보이면 스스로 병이 낫기를 기다리며 병이 나은 뒤에도 약을 써서 조리해야 한다. 그렇지 않으면 후유증이 생길 우려가 있다.

★ 태음인 대변에 따른 가감

태음인병 한궐 4일/5일&무한	웅담산, 한다열소탕 加 제조 *제조(蟬蟪): 굴벙 이 말린 것
대변 묽으면(대변활)	건울, 의이인
대변 굳으면(대변조)	갈근, 대황

- 태음인 신경방 24개에서,

┌ 건울 · 의이인 등이 들어간 처방: 한다열소탕, 태음조위탕

└ 갈근, 대황이 들어간 처방: 열다한소탕, 갈근해기탕

★ 한다열소탕 vs. 태음조위탕: 약재 2개 다름

┌ 한다열소탕: 의이인 나복자 맥문동 길경 마황 건울 **황금 행인**

└ 태음조위탕: 의이인 나복자 맥문동 길경 마황 건울 **오미자 석창포**

★ 열다한소탕 vs 청폐사간탕 ★ 기출: 구성 약재 → 처방명 쓰기 (청폐사간탕)

┌ 열다한소탕: 갈근 황금 고본 나복자 길경 승마 백지

└ **청폐사간탕**: 열다한소탕 + **대황1돈**

* 청폐사간탕은 from 동의사상신편 by 원지상 / 태음인 신경방 24개에 없음

* 열다한소탕, 청폐사간탕은 조열증에 씀

cf) 소음인 적백하오관중탕(피로에 사용) + 후박 지실 목향 대복피 = 십이மிழ황탕